

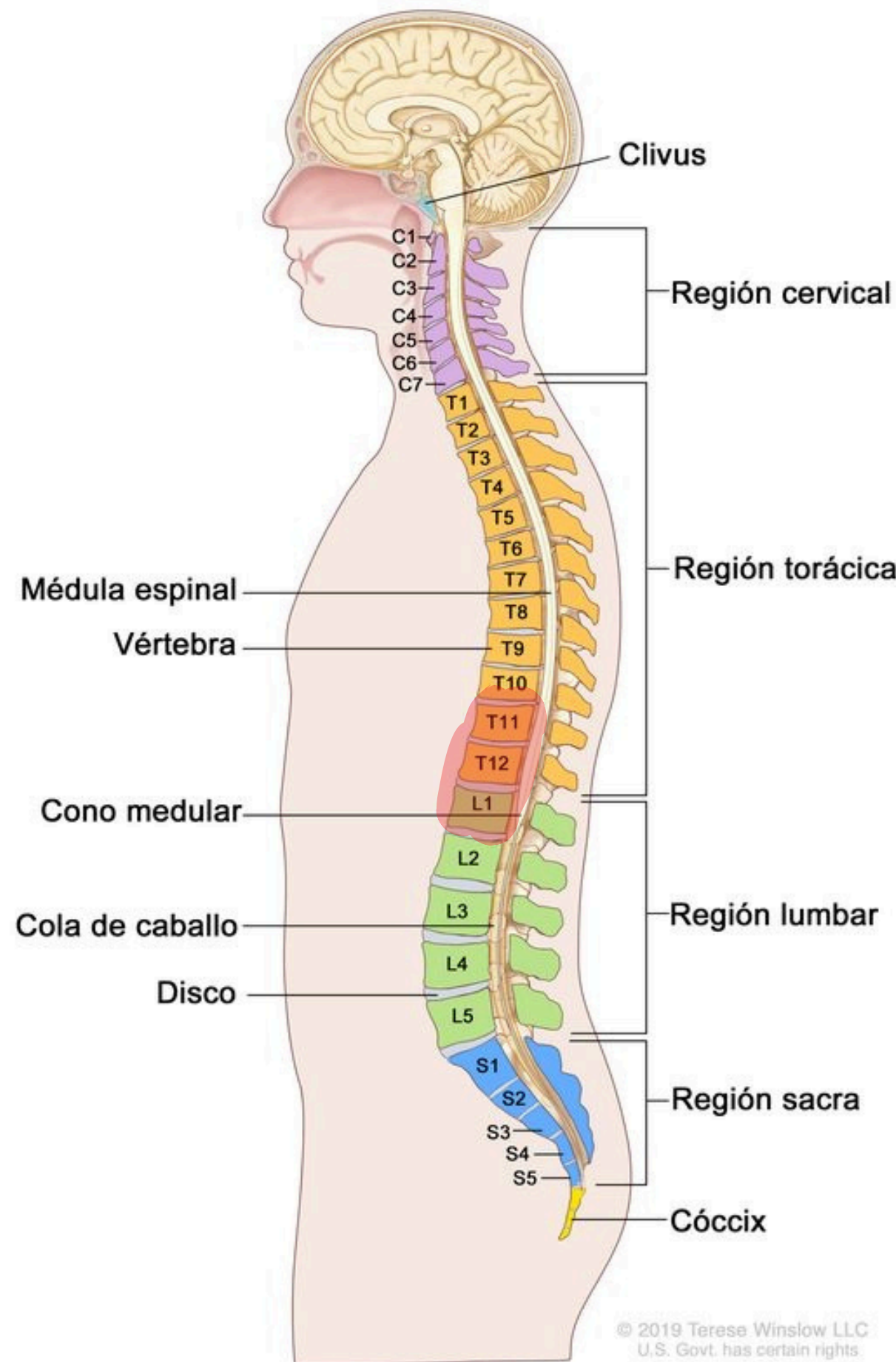
CASO #10:

INTEGRANTES:

- TOLEDO VIERA ALEJANDRO MANUEL
- TINOCO ALEJO, DAMARIS MARIA.
- VALVERDE BARRENECHEA, RIHANNA MIA.
- VICENTE MENDOZA, CARLOS ALONSO.
- VILCHEZ TAPULLIMA, SAMANTHA ANHELIS.
- VILLAR FRECH, DANIELA



Traumatismo de la médula espinal T11/L1 – AIS B



- Caída desde escaleras, 10/09/2025 (Juliaca)
- Pérdida de conciencia + fractura de L1 con compresión medular
- Cirugía el 14/09/2025: fijación dorsolumbar (T11-T12-L2-L3) con tornillos y 2 barras de titanio + laminectomía descompresiva L1

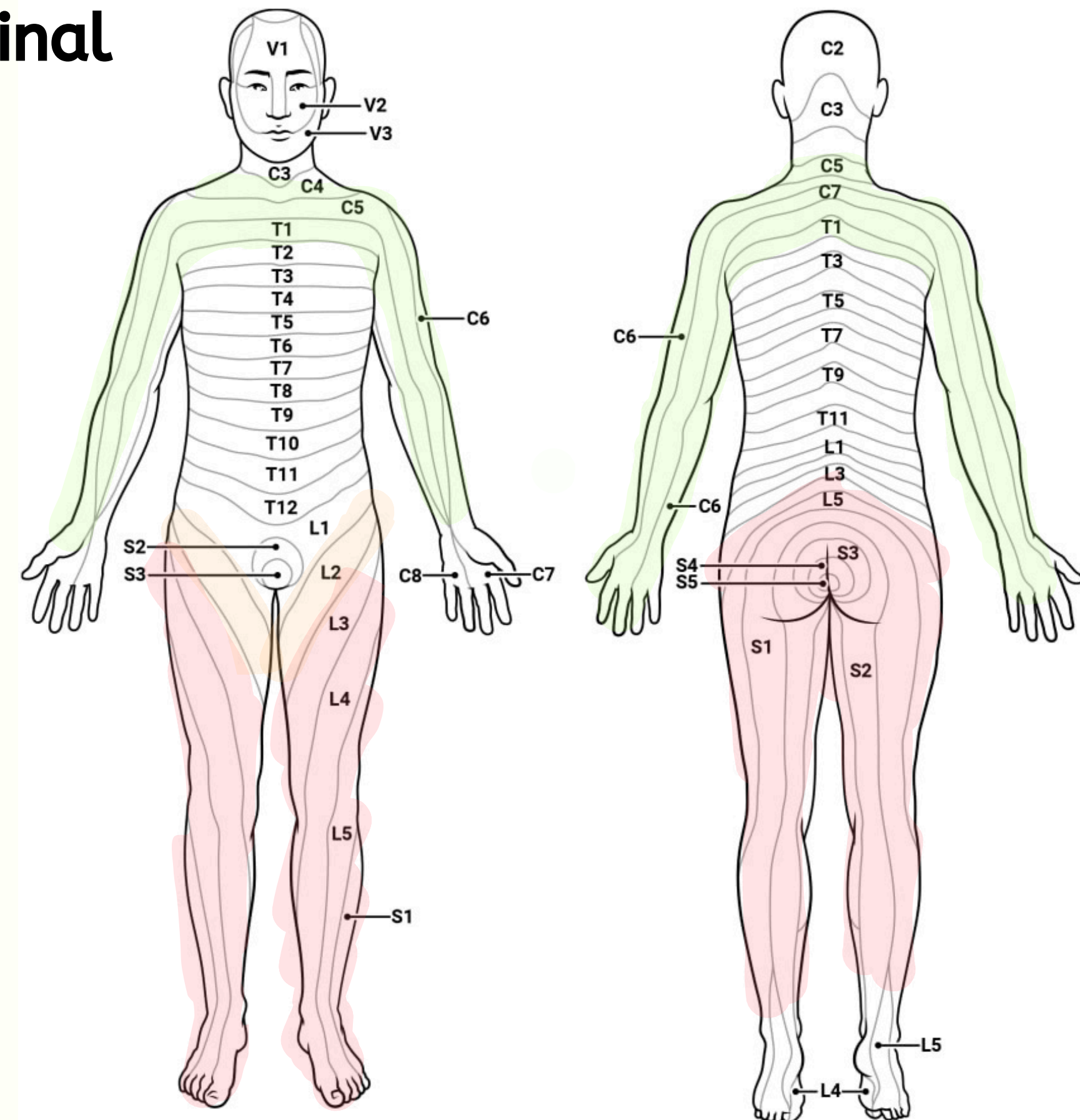
Sistema afectado:

Sistema nervioso central – médula espinal

Fuerza muscular por segmento

Segmento	Fuerza	Estado
C5-T1	5/5	Conservada
L2	3/3	Disminuída
L3-S1	0/0	Abolida

- Tono muscular bajo, hipotrofia moderada en MMI
- Acortamiento de cuádriceps y flexores de cadera
- Este patrón corresponde a la clasificación AIS B



Anatomía y fisiología

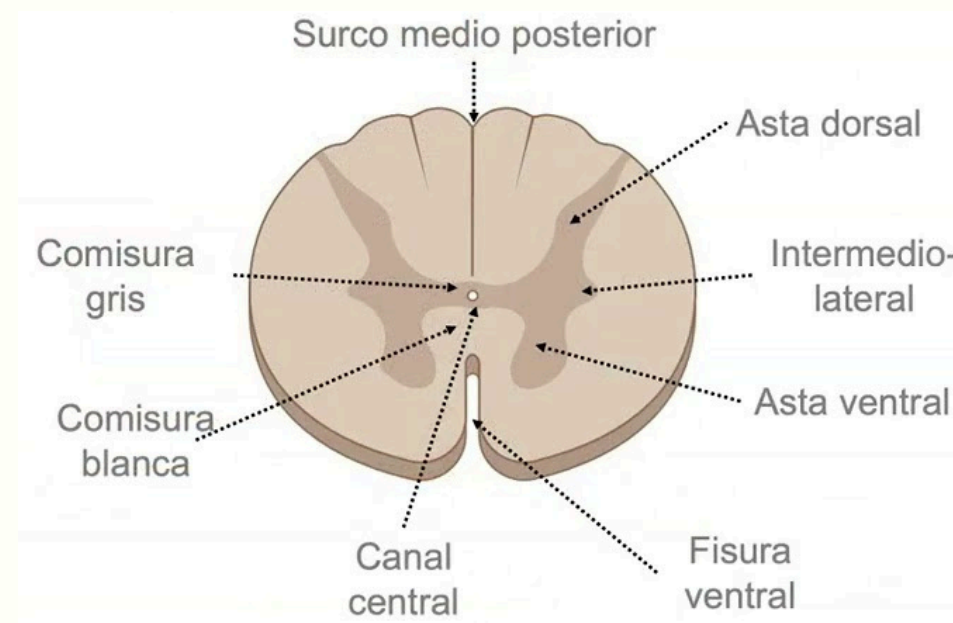
¿Por qué se altera la función por debajo de L1?

Lesión en un nivel



Pérdida de
función por
debajo de ese
punto

Médula espinal desde
un corte transversal



- Médula espinal: canal de comunicación entre encéfalo y cuerpo
- 31 pares de nervios espinales mixtos (raíz anterior motora / raíz posterior sensitiva)
- Sustancia gris (H) + sustancia blanca (tractos ascendentes y descendentes)

Aplicación al caso:

fractura L1



**Daño de vías hacia
MMII**



**AIS B (sensibilidad
conservada,
motricidad abolida
desde L3)**

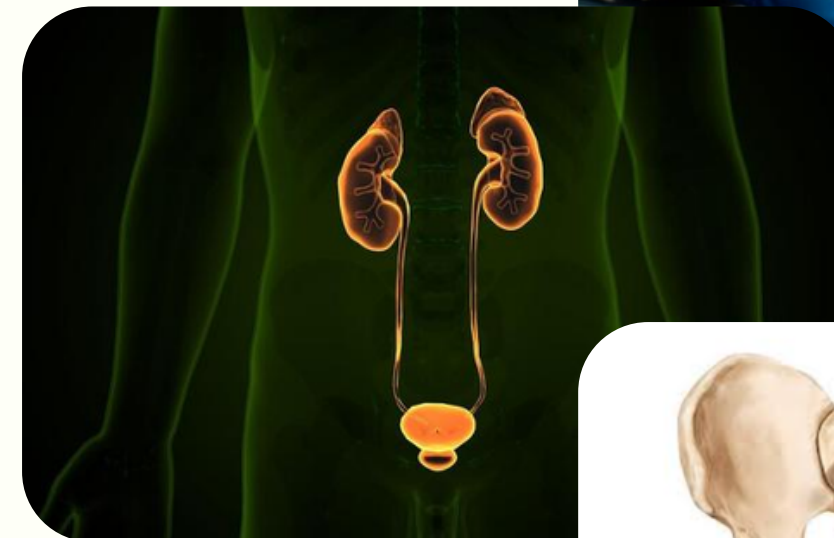
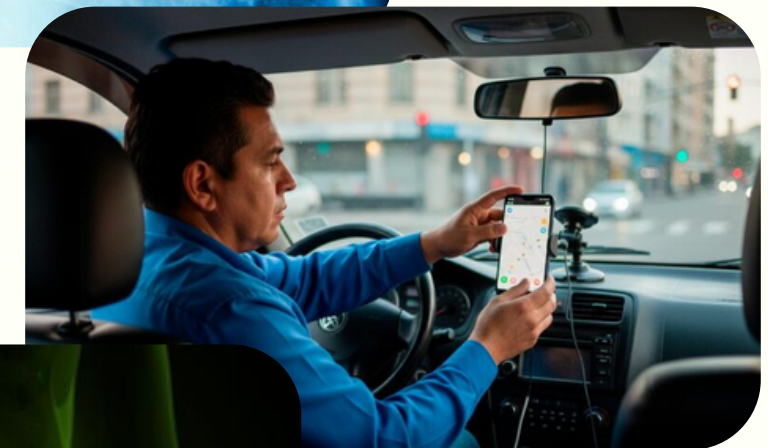
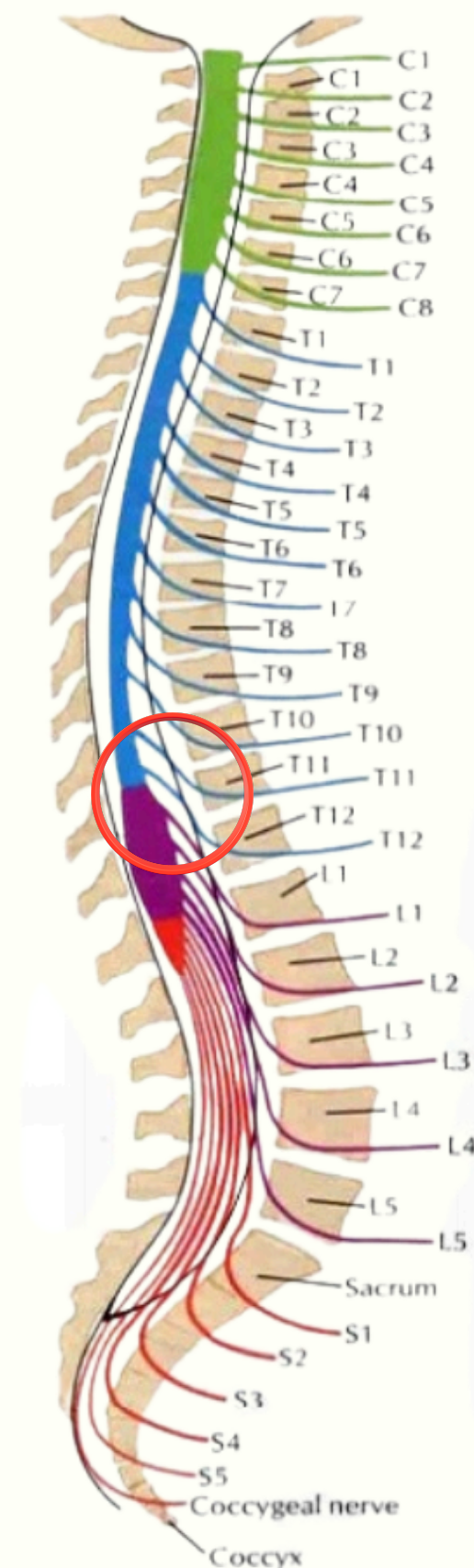
FACTORES DE RIESGO

Secuelas parenquimatosas y pleurógenas de la TBC

Vida sedentaria

Interrupción del control voluntario de la vejiga

Pérdida de sensibilidad en el lado izquierdo del sacro



MANIFESTACIONES CLÍNICAS

► Déficit motor:

Fuerza intacta en brazos (C5-T1: 5/5)

Debilidad/Pérdida en piernas (L2:3/3,L3-S1:0/0)

► Déficit sensitivo:

Hipoalgesia/hipoestesia desde S3/L4 hacia abajo

Sensibilidad sacra conservada (S4-S5 derecho)

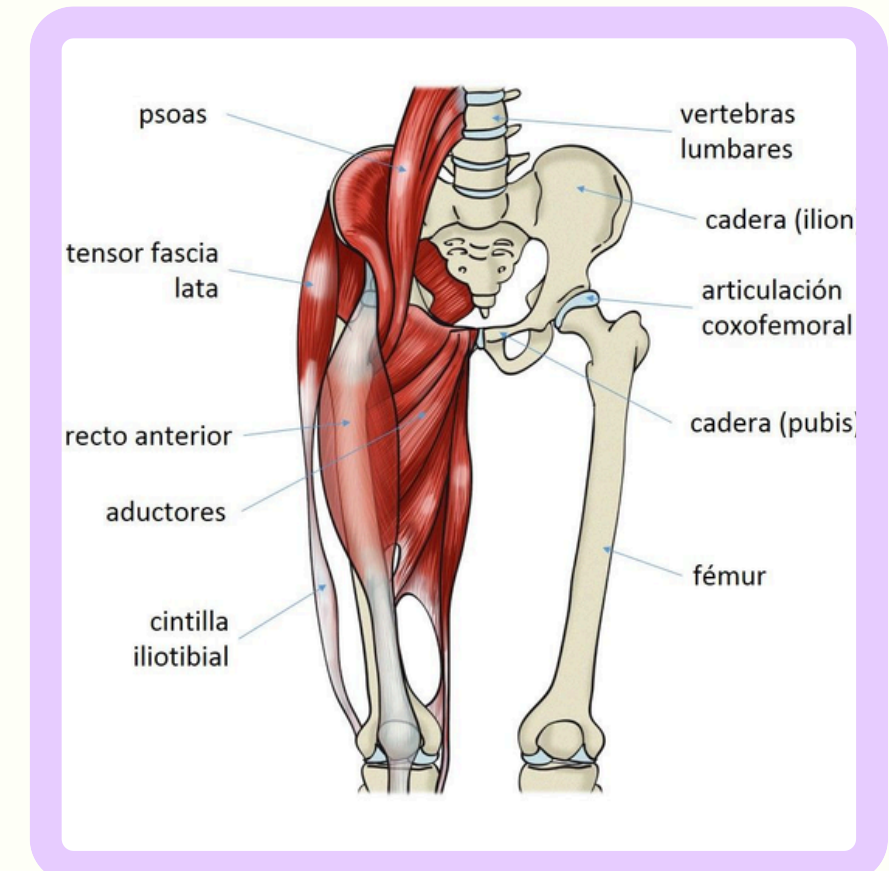
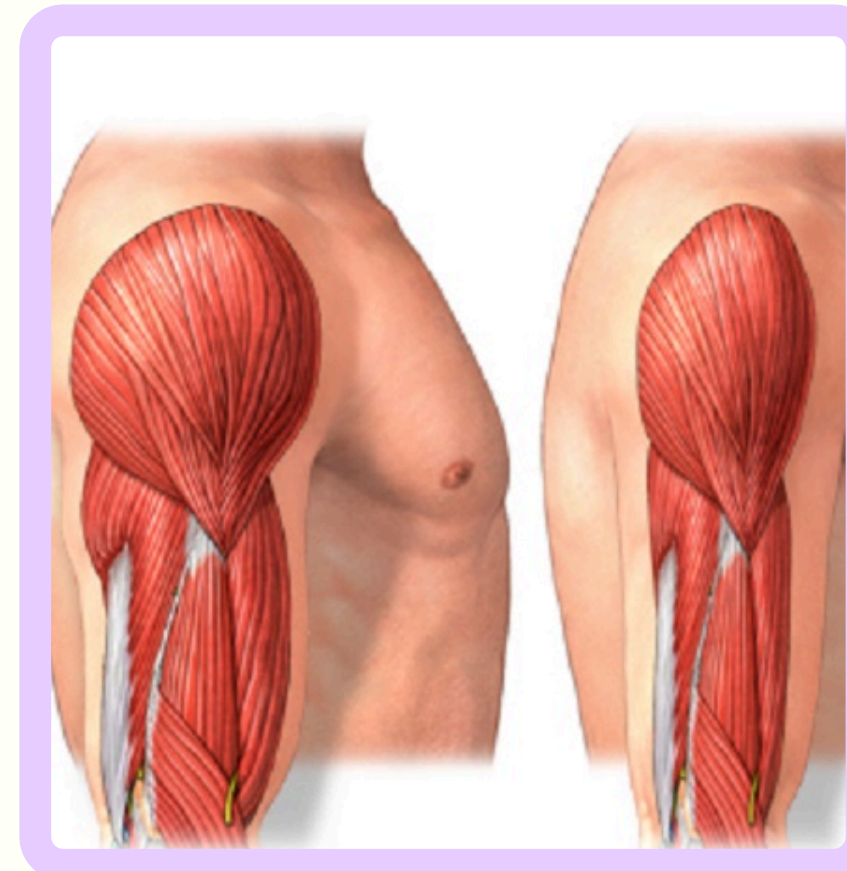
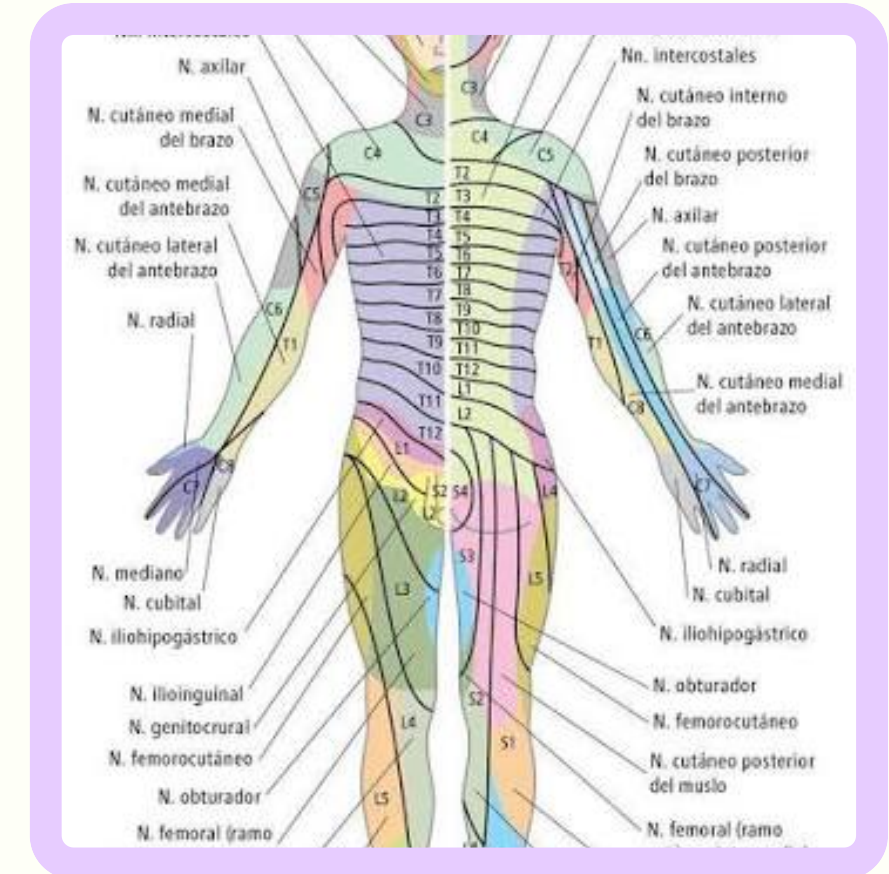
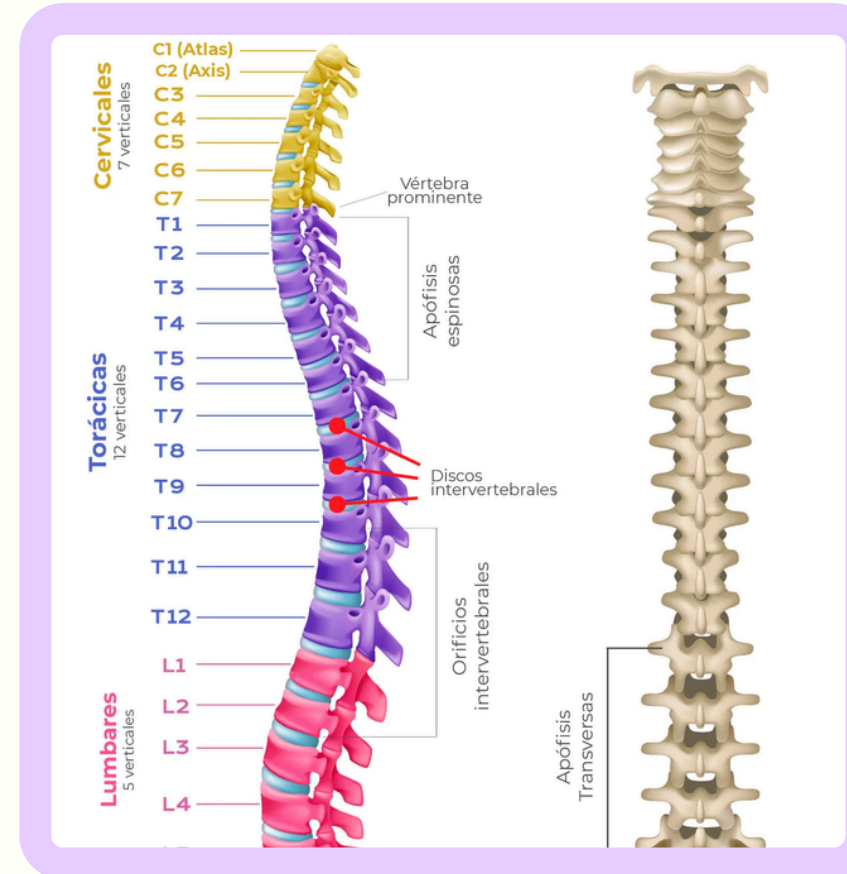
Lesión Incompleta (AIS "B")

► Afectación muscular:

Hipotonía e hipotrofia (pérdida de masa) en extremidades inferiores por desuso.

► Movilidad:

Acortamiento de flexores de cadera y cuádriceps por uso crónico de silla de ruedas.



IMPACTO FUNCIONAL

► Dependencia en locomoción:

Pérdida motora en piernas que obliga al uso diario y estricto de silla de ruedas.

► Autonomía para transferencias:

Fuerza intacta en brazos que permite total independencia en cambios posturales y traslados (silla-cama).

► Pérdida de control de esfínteres:

Afectación de funciones básicas por daño neurológico, limitando la privacidad y autonomía personal

► Reeducación clínica continua:

Necesidad indispensable de un programa especializado de manejo vesical e intestinal para mantener su calidad de vida.



PREVENCIÓN DE COMPLICACIONES

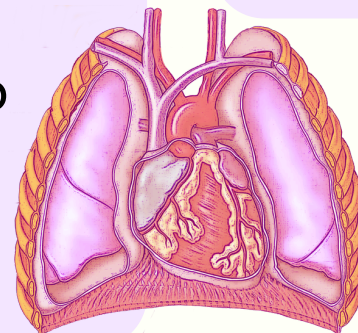
Caso: Traumatismo Medular Torácico (T11, AIS "B")

- **Protección Tisular y Cutánea**

Control biomecánico de presiones para evitar isquemia y úlceras.

- **Estabilización Cardiopulmonar y Vascular**

mantenimiento aeróbico

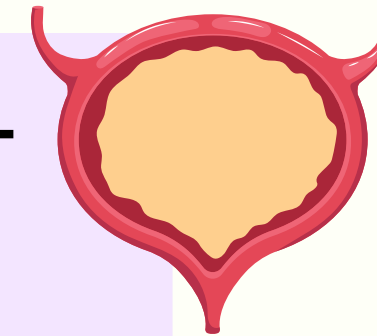


- **Preservación Músculo-Esquelética**

Rango articular pasivo para prevenir contracturas y bipedestación para mitigar osteoporosis.

- **Protección Viscero-Autónoma**

Monitoreo urológico/vesical y protocolo de evacuación intestinal.



- **Soporte de Salud Mental**

Evaluación periódica para la adaptación a largo plazo



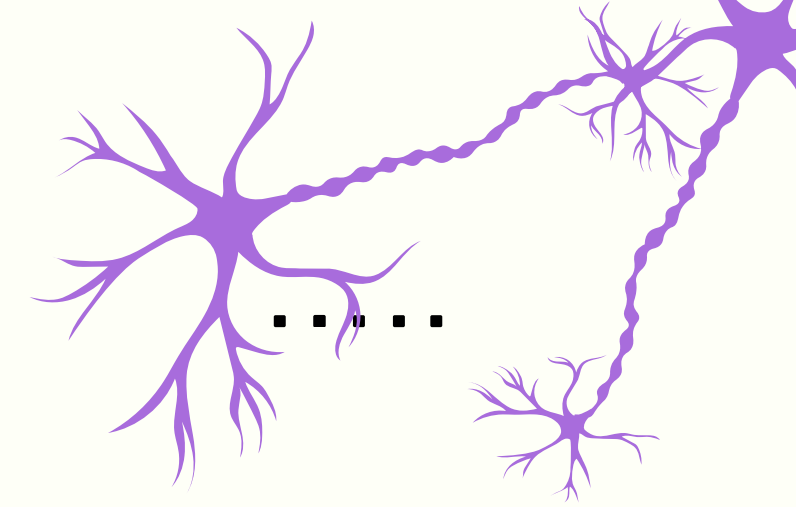
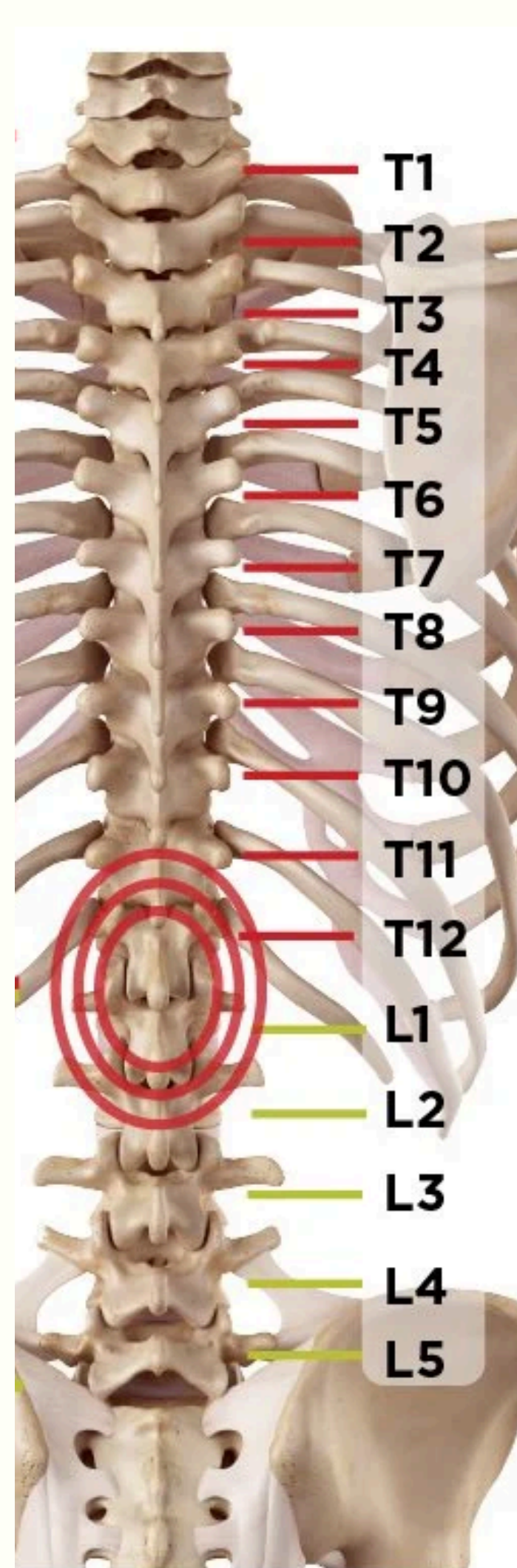
DIAGNÓSTICO DE LA LESIÓN MEDULAR

Evaluación neurológica ISNCSCI

- Función motora y sensitiva
- Nivel neurológico
- Clasificación AIS

T11 AIS B

- T11 → nivel neurológico
- AIS B → sensibilidad preservada sin función motora



Estudios de imágenes

- TC → lesiones óseas
- AIS B → médula y tejidos blandos

CASO:

Fractura de L1 +
comprimiso medular

TRATAMIENTO

Manejo Clínico Integral

Rehabilitador y Biomecánico:

- Movilidad pasiva.
- Fortalecimiento de musculatura
- Bipedestación asistida



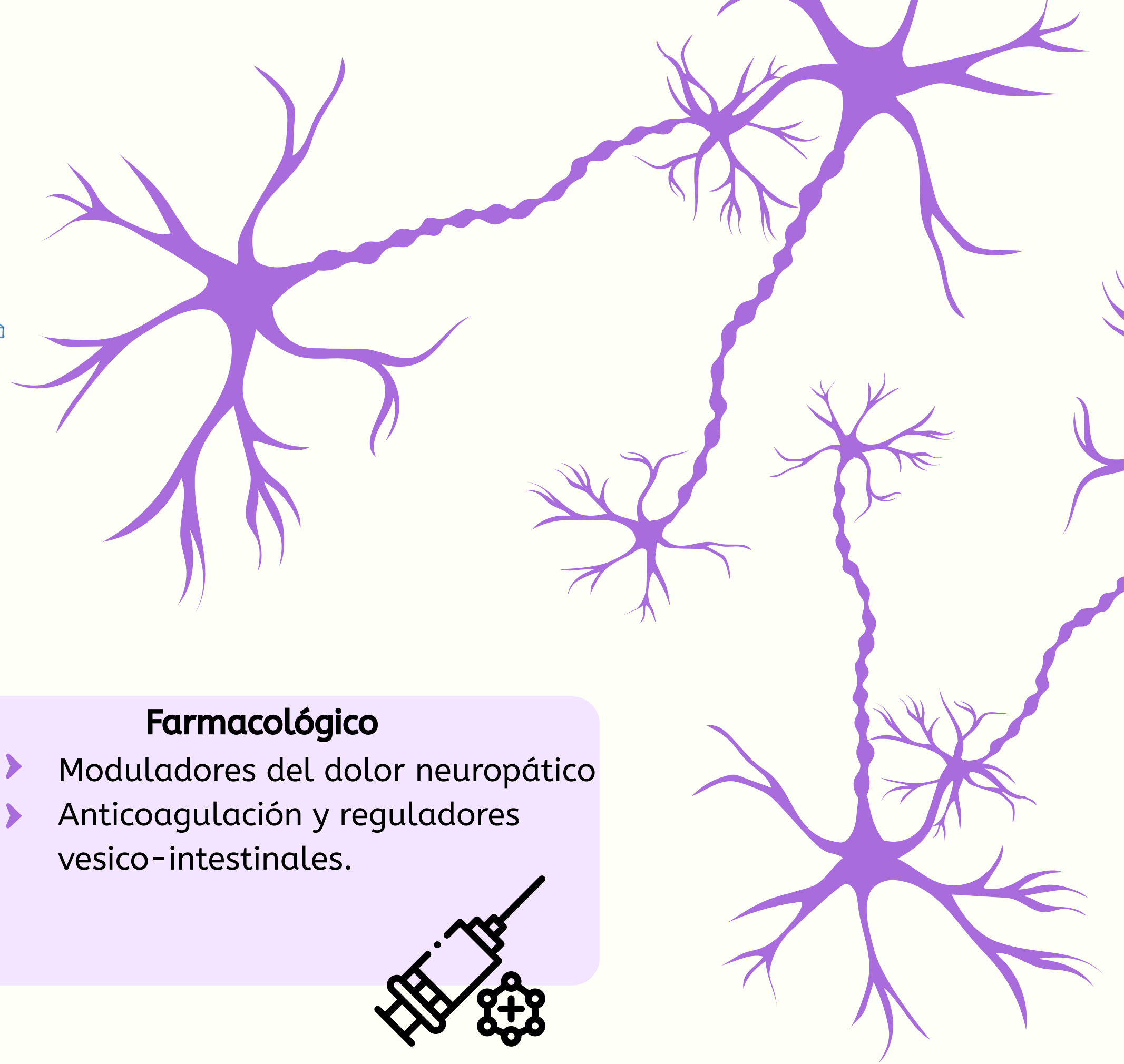
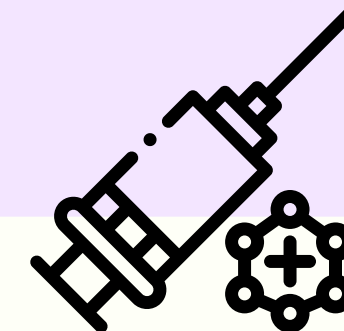
Quirúrgico (Fase Aguda)

- Laminectomía
- Estabilización vertebral con
- Fijación rígida (tornillos y barras).



Farmacológico

- Moduladores del dolor neuropático
- Anticoagulación y reguladores vesico-intestinales.



MONITOREO Y SEGUIMIENTO

Función neurológica

- Motor
- sensitivo
- cambios neurologicos



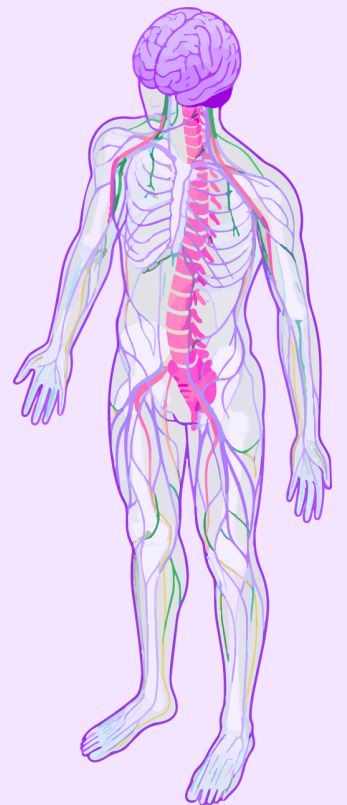
Evolución clínica

- Rehabilitación
- Complicaciones



Imágenes

- Columna
- Médula



OBJETIVO:

Detectar cambios y valorar la evolución de paciente

PROBLEMAS ENCONTRADOS

Diagnostico:

Traumatismo de la médula espinal NN
T11 AIS "B" por caída (T09.3/W19.9)

**Pérdida de soporte y
control motor para la
bipedestación**

**Vulnerabilidad a lesiones
por presión y/o roces ante
perdida de sensibilidad**





PROBLEMAS ENCONTRADOS

.....

Diagnostico: Traumatismo de la médula espinal
NN T11 AIS "B" por caída (T09.3/W19.9)

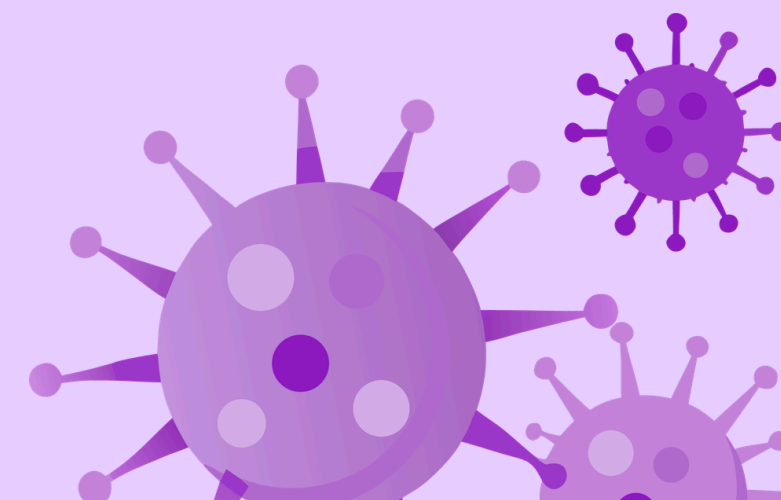
.....

Desconexión neurológica que interrumpe
el control voluntario y la sensibilidad
vesical.

➤ Retención Urinaria

➤ Pérdida de autonomía
miccional

➤ Infecciones Frecuentes



GRACIAS

